

CAT devant une hépatomégalie

Dr.MENOURA .R

**Maitre assistant Hepato-biliopancreatique
Service de chirurgie digestive et endocrinienne
E.H. DIDOUCHE MOURAD**

L'intérêt de la question :

- - Symptôme assez fréquent et alarmant , traduit une atteinte hépatique ou extra hépatique
- - Diagnostic positif facile clinique, aidé parfois par l'échographie AP
- - Orientation étiologique : nécessitant une enquête minutieuse basée sur l'imagerie (multiples étiologies)

II. Rappel anatomique :

- Localisation
- Situé dans l'hypochondre droit, étendu jusqu'à l'épigastre et parfois l'hypochondre gauche.
- Protégé en grande partie par la cage thoracique (côtes 7 à 11).
- Le bord inférieur peut devenir palpable sous le rebord costal en cas d'hépatomégalie.



- **2. Morphologie**

- • **Organe volumineux (environ 1,5 à 2 kg chez l'adulte).**
- • **Divisé en 2 lobes anatomiques (droit et gauche) par le ligament falciforme.**
- • **Classification fonctionnelle en 8 segments de Couinaud, chacun ayant son pédicule vasculaire et biliaire propre (utile en chirurgie et radiologie).**

- **3. Vascularisation**

- **▪ *Afflux sanguin mixte :***

- • **Veine porte hépatique (70–75%) : sang veineux riche en nutriments venant du tube digestif.**
- • **Artère hépatique (25–30%) : sang artériel riche en oxygène.**

- ▣ *Drainage :*

- • **Par 3 veines hépatiques (droite, moyenne, gauche)
→ Veine cave inférieure.**

- □ **4. Voies biliaires**

- • **Foie produit la bile → canaux biliaires intra-hépatiques → conduit hépatique commun → canal cholédoque → duodénum (via ampoule de Vater).**

Fonctions hépatiques

- **Métabolisme** des glucides, lipides, protéines
- **Synthèse** : albumine, facteurs de coagulation
- **Stockage** : glycogène, vitamines (A, D, B12), fer
- **Détoxification** : médicaments, ammoniacque (→ urée)
- **Sécrétion biliaire** (digestion des lipides)

III. Interrogatoire orienté

Objectifs :

Identifier des éléments d'orientation vers une étiologie.

Points clés :

.Terrain : âge, antécédents médicaux, consommation d'alcool, voyage, facteurs de risque viral.

- **Symptômes associés :**
 - Fièvre, fatigue, amaigrissement (infection, tumeur)
 - Douleur hépatique (abcès, congestion)
 - Ictère (hépatite, obstruction biliaire)

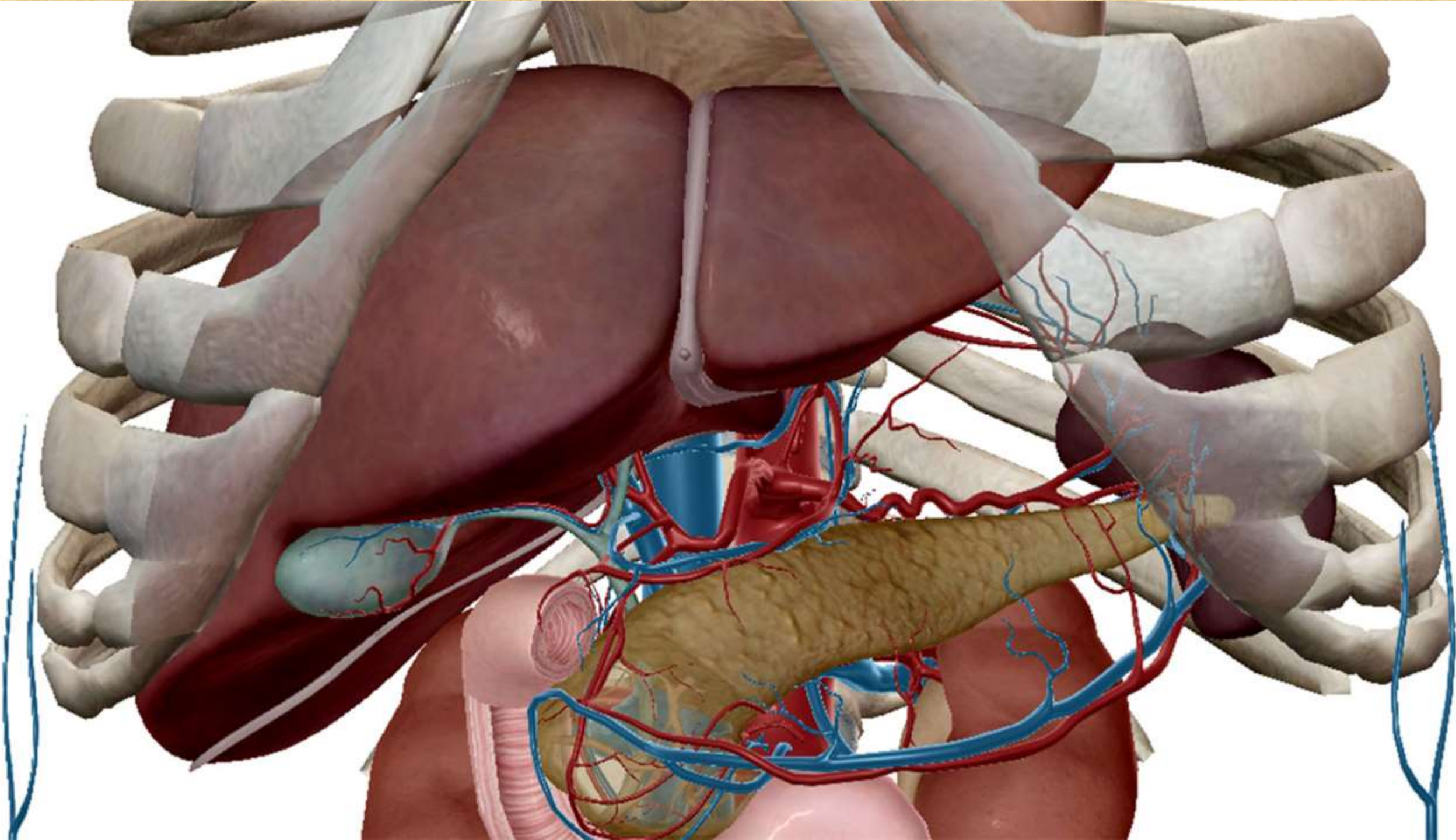
◦ Signes d'insuffisance cardiaque droite

.Traitements récents (toxicité médicamenteuse)

.Exposition professionnelle ou alimentaire (toxiques, champignons, métaux lourds)

LE FOIE

- Le mot grec pour foie est « **hepar** » — c'est pourquoi les mots médicaux associés au foie commencent souvent par « **hépat** » ou « **hépatique** ».
Les Grecs considéraient que le foie était le siège des **émotions**. Ils pratiquaient « l'hépatoscopie » au cours de laquelle on sacrifiait des bœufs ou des chèvres pour examiner leur foie afin de déterminer la réussite ou l'échec de leurs **campagnes militaires**.
- Les Grecs considéraient le foie comme **l'organe le plus étroitement en contact avec les divinités**



Veine sus-hépatique
sagittale (dans la
grande scissure)

Veine sus-hépatique
droite

Canal latéral droit

Canal
paramédian
droit

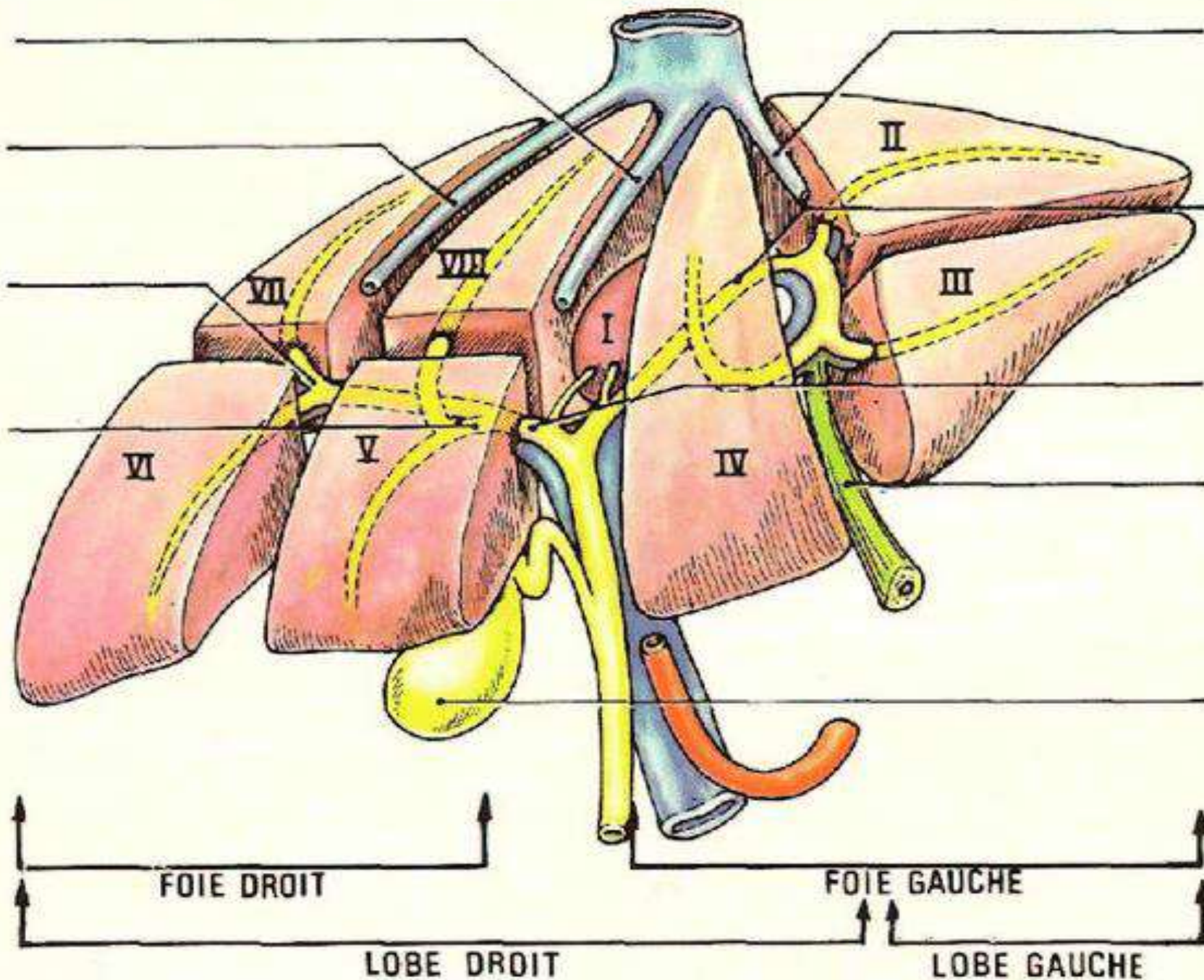
Veine sus-hépatique
gauche

Canal hépatique
gauche

Canal hépatique
droit

Ligament rond
prolongeant
le récessus de Rex

Vésicule



Ex clinique : Le foie normal:

- **Dimension : FH = 10- 12 cm (LMC)**
- **Consistance : élastique**
- **Sensibilité : absente**
- **Surface du foie : lisse**
- **Le bord inferieur : régulier , aigu**
- **Mobile pendant la respiration**

Flèche hépatique

Bord sup : percussion



**Bord inf : palpation
(percussion)**

Diagnostic et clinique

- Après examen clinique : une Masse de l'HCD, mobile avec les mouvements respiratoires. apprécier les caractères
- Eliminer ce qui n est pas une hépatomégalie :

Devant une HPM diffuse :

Foie ptosé : bord in palpable mais FH normale

Foie luxé : foie refoulé vers le bas /1 processus thoracique pathologique (épanchement pleural liquidien +++....)

Lobe de Riedel

languette qui occupe le flanc droit en contact avec le foie
=hypertrophie des secteurs ant du foie droit , descendant jusqu'à la FID



2) Devant une HPM localisée

- **A développement abdominal :**
- **Grosse vésicule : sillon ,écho.**
- **Gros rein droit :contact lombaire + urinaires , écho voire UIV .**
- **Tm surrénalienne :sympt. Évocatrice ,TDM .**
- **Tm de l'angle colique droit : Tb du transit ?colo. LB**
- **V3 Tm gastrique : s.d'appel ,FOGD**
- **Kyste et PKP : écho. TDM abdominale .**
- **Tm pariétale : écho pour confirmer et redresser le malade .**



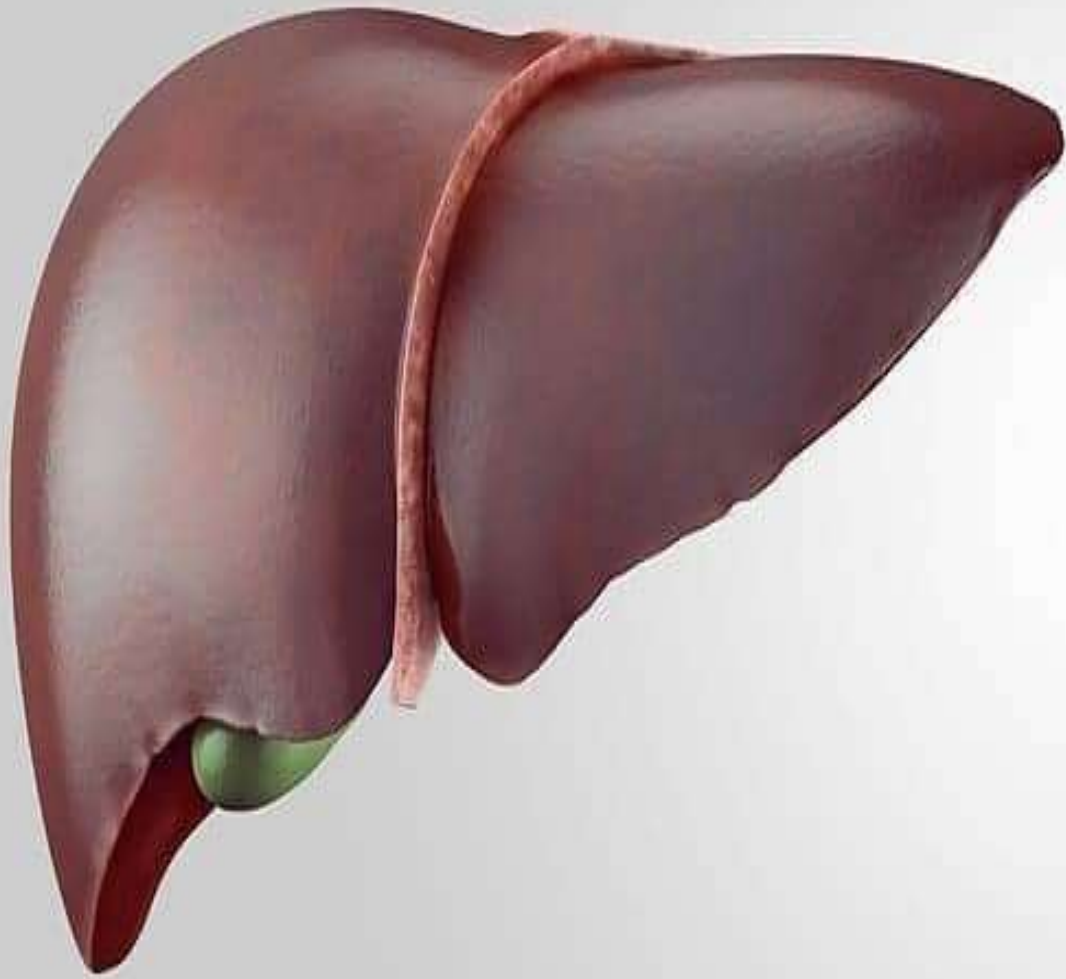
II/ *Etiologies*

L'hépatomégalie (HMG) peut être
(après les données clinique et
échographique)

1. diffuse, homogène, sans nodule
2. homogène mais sectorielle
3. hétérogène, avec nodule

Homogène et diffuse

ETIO	CLINIQUE	PARACLINIQUE
Hépatite aigüe	HMG, DOULOUREUSE, ictère	Séro des hépatites virales
<u>Cirrhose</u>	HMG indolore à bord inf. tranchant Signe d'HTP et d'IHC	Echo / bio Bilan cirrhose ± biopsie
Causes métabo-toxiques *	HMG indolore à bord mousse	Foie hyperéchogène (stéatose) Bilan métabo / fer
<u>Foie congestif</u>	HMG douloureuse, <u>autres signes d'ICDte</u>	Dilatation des veines hépatiques ECG, ETT
Cholestase prolongée	Ictère chronique	Voie biliaire dilatée, cholestase Cholangio-IRM si dilatation des VBI



healthy liver



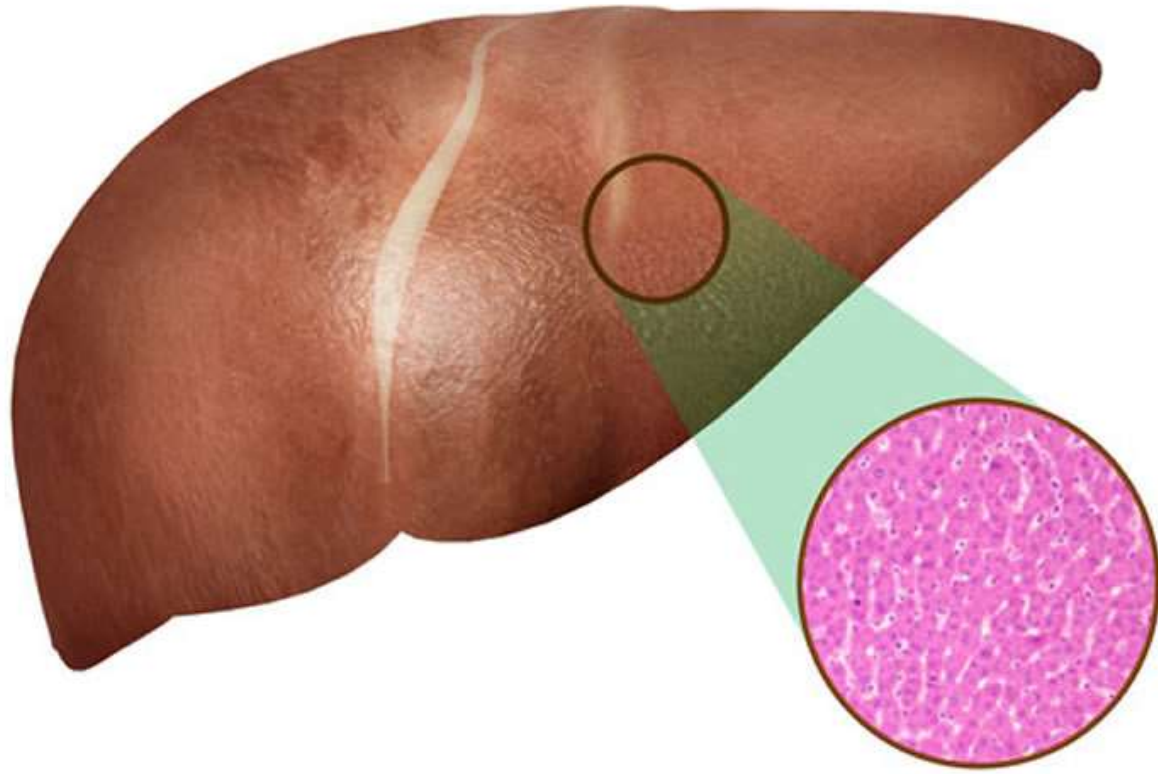
cirrhosis



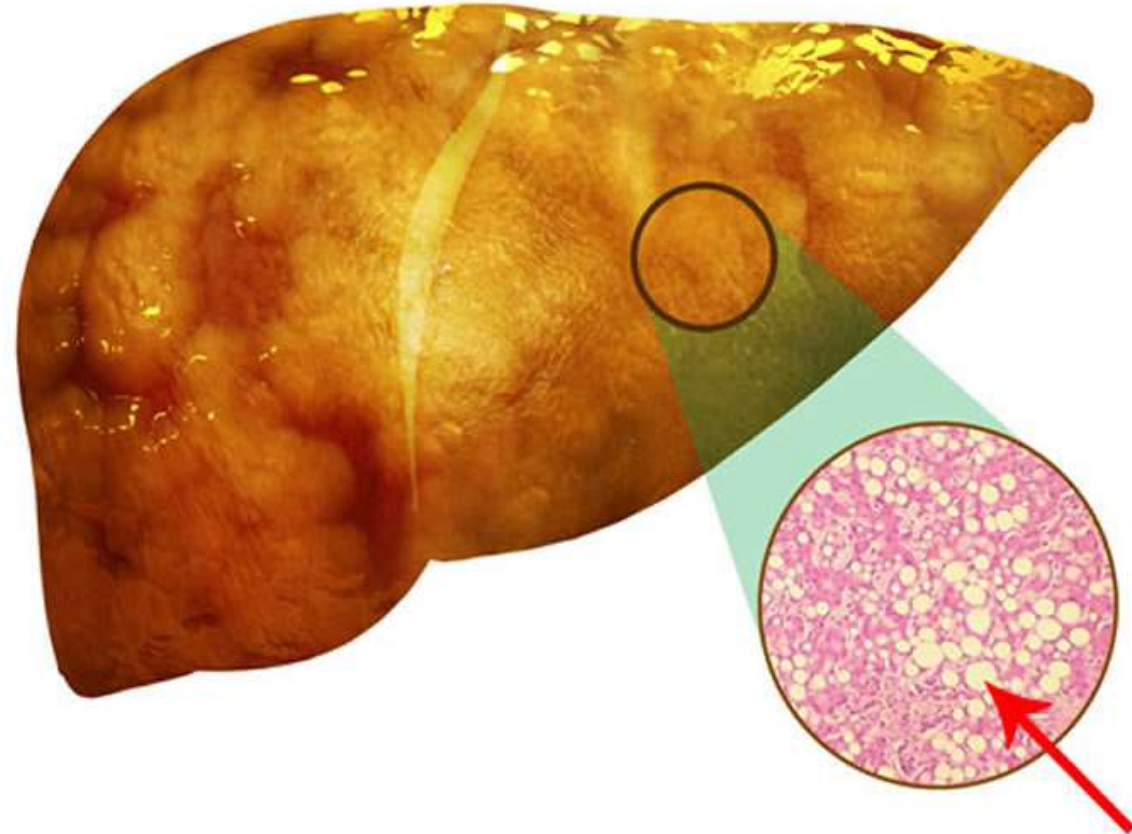
FOIE GORGE DE SANG FOIE CARDIAQUE

- *** Les causes métabo-toxiques regroupe la stéatose alcoolique et non alcoolique, l'hémochromatose et les hépatites médicamenteuses**

Hemochromatosis



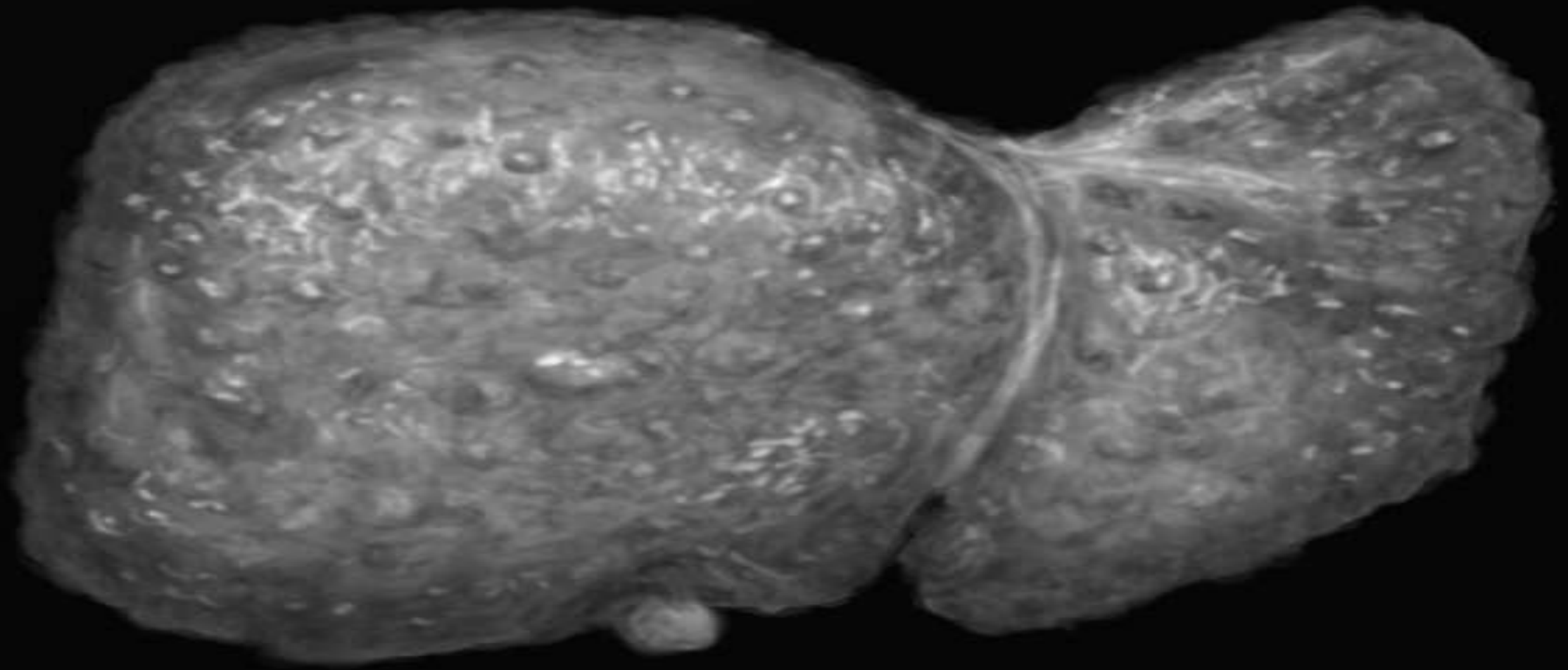
Healthy Liver



Hemochromatosis Liver

- **Too much iron (iron overload) can poison your organs and cause organ failure. Normally your body controls iron levels by absorbing just the right amount of iron from your food**

HEPATITES MEDICAMENTEUSES



U. Götz

Homogène et sectorielle

ETIO

CLINIQUE

PARACLINIQUE

Cirrhose

**HMG indolore à bord inf. tranchant
Signe d'HTP et d'IHC**

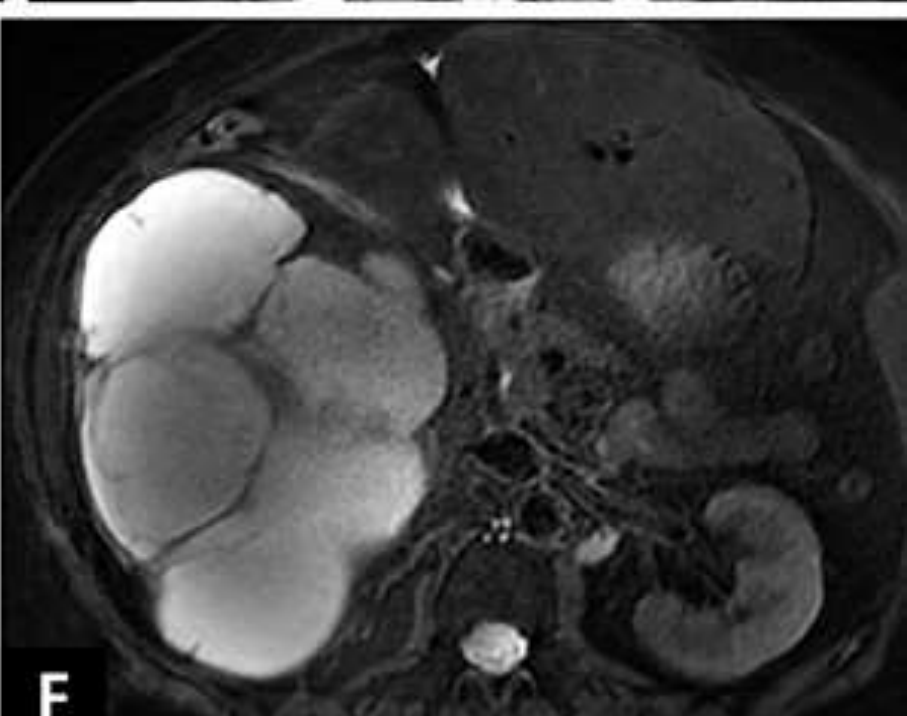
**Bio / écho
± Biopsie**

Hétérogène, avec nodules

ETIO	CLINIQUE	PARACLINIQUE
<u>Cirrhose</u>	HMG indolore à bord inf. tranchant Signe d'HTP et d'IHC	Bio / écho ± Biopsie
<u>Tumeur hépatique</u>	HMG dur, parfois multinodulaire ± AEG dans les tumeurs malignes	
Abcès à pyogène / parasitaire *	HMG douloureuse, fièvre, frisson Terrain particulier	Image spé écho /TDM Séro amibiase, hémoc.
Polykystose hépatique / <u>hépatorénale</u>	Kyste	Image spé écho /TDM

- *** Principales causes parasitaires :**
 - kyste hydatique
 - échinococcose alvéolaire
 - amibiase hépatique





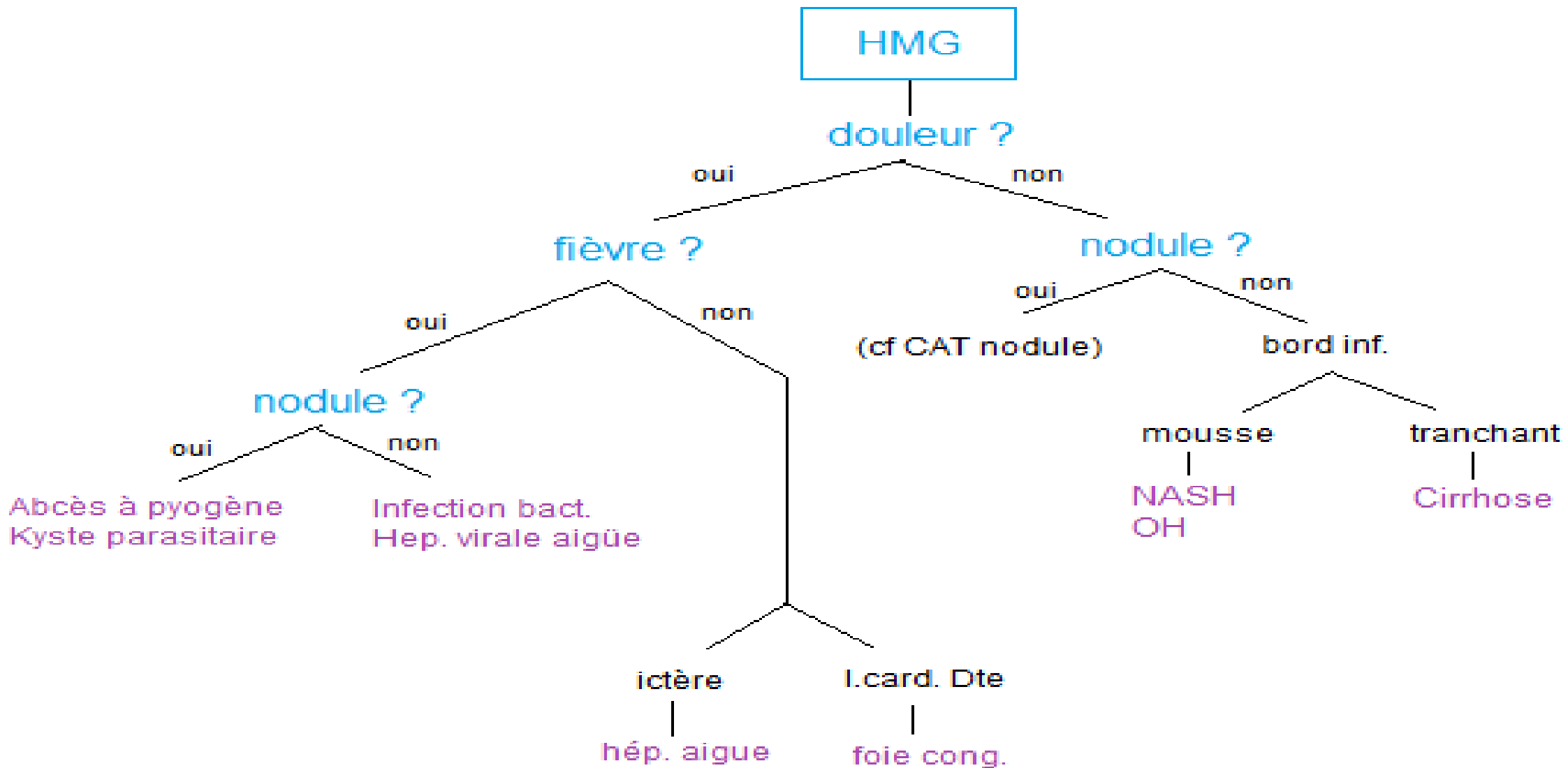
info-radiologie.ch

CHC



- **Orientation diagnostique**
- **Caractéristiques du foie**
 - HMG diffuse ou sectorielle, homogène ou non
 - HMG douloureuse
 - Bord inférieur mou ou tranchant (signe peu sensible)
- **Signes généraux et FdR d'hépatopathie aiguë ou chronique**
- **=> *Au total, on peut déjà orienter le diagnostic avec l'arbre suivant (mais les signes sont trop peu sensible pour poser le diagnostic)***

(ORIENTATION CLINIQUE SIMPLIFIEE)



B) Paraclinique

- **Bilan de 1^{ère} intention (systématique)**

BILAN DEVANT UNE HMG

Imagerie : échographie hépatique

Biologie

- NFS
- Bilan hépatique = transaminase, phosphatase alcaline, GGT, TP, bilirubinémie, EPP

Examens de 2e intention selon les données cliniques et échographiques

CIRCONSTANCE	EXAMENS COMPL.
HMG diffuse / homogène	Bilan spé selon suspicion clinique / paraclinique En l'absence de diagnostic => PBH
HMG sectorielle / homogène	<u>Bilan de cirrhose</u>
HMG inhomogène	Cf. <u>CAT devant une tumeur du foie</u>

CI à la ponction-biopsie hépatique trans-pariétale (PBH)

- Dilatation diffuse des voies biliaires intra-hépatiques
- Trouble de l'hémostase non-corrigé * :
plaquettes < 60 G/L, TP < 50%, TCA allongé
- Ascite *

C) Synthèse

Hépatomégalie

Échographie

homogène

hétérogène

Contexte
clin

apparemment
isolée

pleine

kystique

Cardiaque
Hémato
Infectieuse

rech HTP

marq
TDM / IRM
PBF guidée

TDM
marq
sérol

oui

non

doppler

sus_hep
B. Tse

intra-hep
PBF, BAI, sérol..

s/ hep

orientation
selon S. associées



HMG

examen clinique
et
bilan 1ere intention

HMG homogène
et sectorielle

bilan cirrhose

Cirrhose

HMG homogène
et diffuse

bilan orienté selon
suspicion clinique

dg posé

Cirrhose
Hépatite
Cause métabo-toxique
Foie congestif
Cholestase prolongée

dg non
posé

PBR

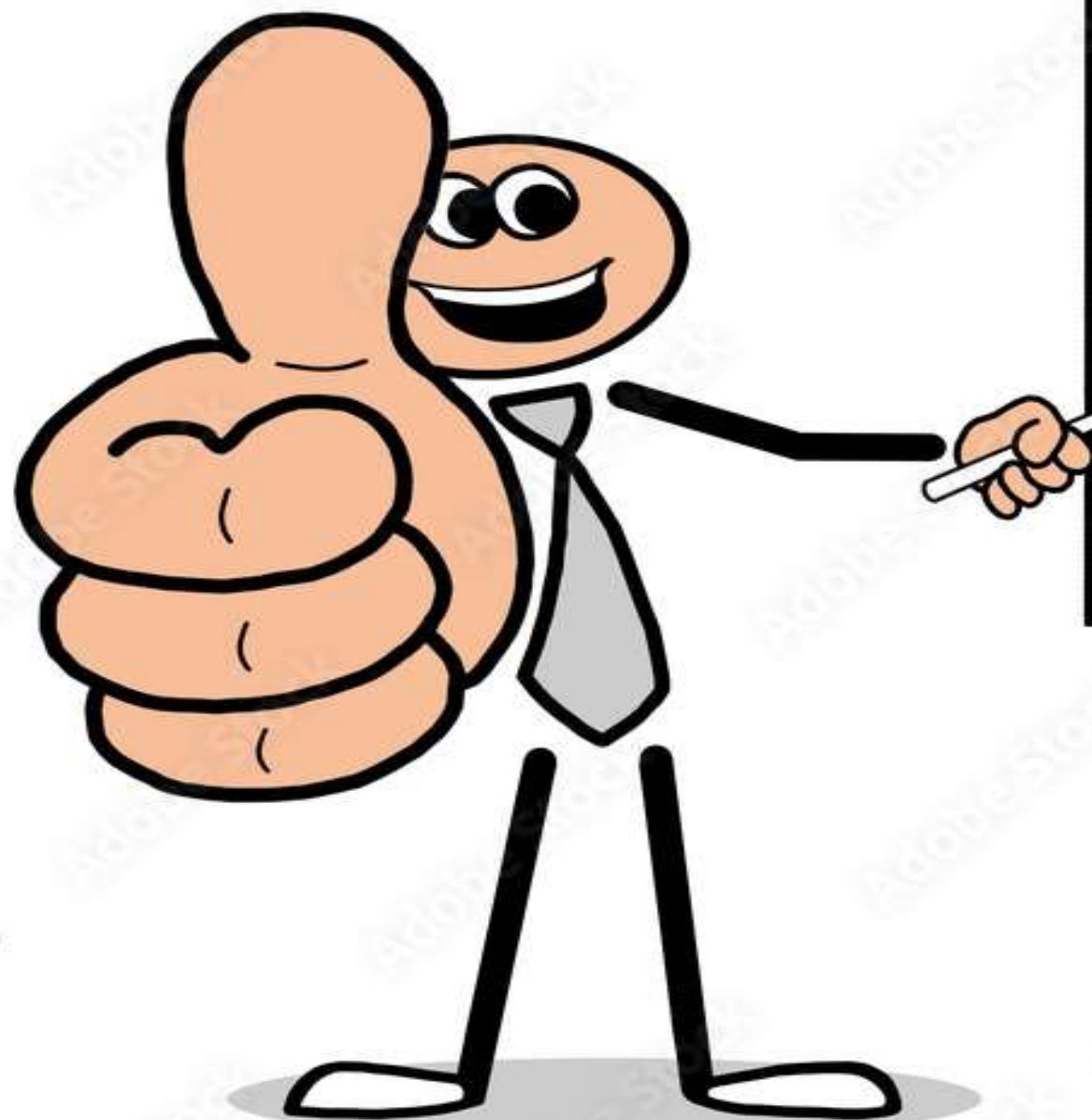
nodules

cf CAT devant un nodule
hépatique

Cirrhose
Tumeur bénigne
Tumeur maligne
Abscess / parasite
Polykystose

CONCLUSION

- **HPM= sympt fréquent de consultation en GE**
- **Le Dc + ne pose plus autant de problème en raison des moyens d'exploration notamment radiologique (échographie) .**
- **Cependant tout l'intérêt de la question réside dans le Dc étiologique devant la diversité des pathologies pouvant affecter le foie Néanmoins , il reste dominé en Algérie par la cirrhose , le KH et la Tm maligne du foie**



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!

